BỆNH ÁN VIÊM PHỔI SƠ SINH — TRẺ NAM 25 NGÀY TUỔI

Bộ câu hỏi vấn đáp kèm đáp án mẫu

Nền: WHO Pocket Book 2013 & hướng dẫn nhiễm khuẩn nặng ở trẻ nhỏ (PSBI) 2015, AAP Red Book (Chlamydia, ho gà, liên cầu B), AAP 2021 (trẻ sốt 8–60 ngày tuổi), BTS/PIDS cho phần chung · Bản 30/10/2026

Thông điệp quan trọng nhất của ca này: trẻ **< 28 ngày** → mọi viêm phổi được xử trí như **nhiễm khuẩn nặng**: **nhập viện, kháng sinh tiêm (ampicillin + gentamicin), tìm nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não**. Triệu chứng **không điển hình** (bú kém, ngừng thở, hạ thân nhiệt, sùi bọt), ho và sốt có thể không có. Ở tuổi 25 ngày, nhớ thêm **Chlamydia trachomatis, ho gà, RSV** và **bệnh tim bẩm sinh** (dễ nhầm với viêm phổi).

A. Mở đầu – khái niệm

1. Bé 25 ngày tuổi thuộc giai đoạn nào? Viêm phổi sơ sinh chia thế nào, bé này thuộc loại nào?

Sơ sinh = **0–28 ngày**; 25 ngày là **sơ sinh muộn**. Viêm phổi sơ sinh: **khởi phát sớm** (thường < 72 giờ, có tài liệu lấy < 7 ngày) — lây **dọc từ mẹ** (trong tử cung, lúc sinh): liên cầu B, E. coli, Listeria, Klebsiella; **khởi phát muộn** (> 7 ngày) — **mắc phải sau sinh**: ở bệnh viện (Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, tụ cầu, nấm) hoặc ở cộng đồng (virus, tụ cầu, phế cầu, liên cầu B muộn, Chlamydia, ho gà). Bé này: **viêm phổi sơ sinh muộn**, cần nói rõ **mắc phải cộng đồng hay bệnh viện** (đã ra viện bao lâu, có nằm viện/thở máy/đặt catheter không).

2. Vì sao sơ sinh dễ bị viêm phổi và nặng?

Miễn dịch non: IgA, IgM thấp (IgG chủ yếu từ mẹ), bổ thể và chức năng bạch cầu đa nhân kém → nhiễm khuẩn dễ lan thành nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. **Hô hấp**: đường thở nhỏ, lồng ngực mềm, thở bằng cơ hoành, cơ hô hấp dễ mệt, **trung tâm hô hấp chưa trưởng thành → ngừng thở**, phản xạ ho yếu, tiêu thụ oxy cao. **Điều hòa thân nhiệt kém**.

3. Vì sao triệu chứng viêm phổi sơ sinh không điển hình?

Phản xạ ho chưa hoàn thiện → **ít ho**; đáp ứng sốt kém → có thể **sốt hoặc hạ thân nhiệt**; biểu hiện chủ yếu là **toàn thân**: bú kém, bỏ bú, li bì, vàng da tăng, nôn, chướng bụng; và **hô hấp**: thở nhanh, ngừng thở, tím, thở rên, rút lõm, **sùi bọt cua** (đờm dãi trộn khí do trẻ không ho khạc, không nuốt hết). Nghe phổi có thể **không thấy ran**.

B. Bệnh sử – tiền sử

4. Bệnh sử cần khai thác những gì ở trẻ sơ sinh?

- Ngày bệnh, khởi phát; **bú**: lượng bú so với bình thường, bú mệt, bỏ bú, **ho/sặc khi bú**, nôn trớ.
- **Thân nhiệt** (sốt hay lạnh), **tím, cơn ngừng thở**, thở rên, sùi bọt; li bì, co giật; số tã ướt, phân.
- **Ho cơn** kéo dài, đỏ mặt, tím sau cơn → ho gà; **chảy mắt, ghèn mắt** trước đó → Chlamydia.
- **Tiếp xúc người bệnh**: anh chị cảm, người lớn ho kéo dài (ho gà), người nhà lao.
- Thuốc, kháng sinh đã dùng; nơi đã điều trị.

5. Tiền sử sản khoa – chu sinh hỏi gì? Vì sao?

Mục	Ý nghĩa
Tuổi thai, cân nặng lúc sinh, cách sinh, Apgar, hồi sức, nằm sơ sinh/thở máy/catheter rốn	Non tháng, nhẹ cân → nặng, ngừng thở; nằm viện → **tác nhân bệnh viện**, loạn sản phế quản phổi
Ối vỡ sớm > 18 giờ, mẹ sốt khi chuyển dạ, viêm màng ối, nhiễm khuẩn tiết niệu	Yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh
Mẹ **mang liên cầu B**, có được kháng sinh dự phòng trong chuyển dạ	Liên cầu B (khởi phát muộn vẫn gặp đến 3 tháng)
Mẹ nhiễm **Chlamydia, lậu, giang mai, HIV, viêm gan B, herpes**, khí hư, viêm cổ tử cung	Chlamydia trachomatis (viêm phổi 1–3 tháng), giang mai bẩm sinh, HSV, PCP
Mẹ tiêm **vắc xin ho gà (Tdap)**, cúm, RSV khi mang thai	Bảo vệ thụ động; chưa tiêm → nghĩ ho gà, cúm, RSV
Bé đã tiêm **BCG, viêm gan B** chưa	Tiêm chủng theo lịch sơ sinh
Cân nặng hiện tại so với lúc sinh, vàng da kéo dài	Tăng cân kém; vàng da > 14 ngày (đủ tháng) cần tìm nguyên nhân (ứ mật, nhiễm khuẩn tiết niệu, suy giáp)

C. Khám

6. Thở nhanh ở bé này là bao nhiêu? Đếm thế nào?

≥ 60 lần/phút (< 2 tháng). Đếm **đủ 1 phút** khi trẻ nằm yên, không bú, không khóc; nếu ≥ 60 thì **đếm lại lần 2** (sơ sinh thở không đều, có **thở kiểu chu kỳ** – ngừng < 20 giây là sinh lý). **Ngừng thở bệnh lý**: ngừng ≥ 20 giây, hoặc ngắn hơn kèm tím/nhịp tim chậm.

7. Rút lõm lồng ngực ở sơ sinh đánh giá thế nào?

Sơ sinh lồng ngực mềm nên **rút lõm nhẹ có thể sinh lý** → chỉ tính **rút lõm nặng** (sâu, dễ thấy). Theo WHO/IMCI trẻ nhỏ: rút lõm lồng ngực nặng là dấu hiệu của **nhiễm khuẩn nặng**.

8. Kể các dấu hiệu "bệnh rất nặng / nhiễm khuẩn nặng có thể" ở trẻ < 2 tháng (WHO/IMCI).

Bú kém hoặc bỏ bú; **co giật**; **thở nhanh ≥ 60**; **rút lõm lồng ngực nặng**; **sốt ≥ 37,5 °C hoặc hạ thân nhiệt < 35,5 °C**; **chỉ cử động khi kích thích hoặc không cử động**. Có ≥ 1 dấu hiệu → điều trị như nhiễm khuẩn nặng, nhập viện.

9. Chỉ số Silverman là gì? Dùng thế nào?

Thang đánh giá suy hô hấp sơ sinh, 5 mục, mỗi mục 0–2 điểm: **(1) di động ngực – bụng** (đồng thì → ngực xẹp, bụng phồng), **(2) co kéo liên sườn**, **(3) lõm hõm ức (mũi ức)**, **(4) phập phồng cánh mũi**, **(5) thở rên**. **Điểm càng cao càng nặng** (0 là bình thường; ngưỡng chia mức theo giáo trình bộ môn). Dùng chủ yếu cho sơ sinh, nhất là non tháng.

10. Khám toàn thân ở sơ sinh cần chú ý những gì? Mỗi dấu hiệu để làm gì?

Khám	Tìm gì
Thân nhiệt, đường máu mao mạch	Hạ thân nhiệt, hạ đường huyết — hay gặp, nguy hiểm
Thóp	Thóp phồng → **viêm màng não**; thóp lõm → mất nước
Da: màu, vàng da, nốt mủ, nổi vân tím, thời gian đổ đầy mao mạch	Tím trung ương; vàng da; mụn mủ → tụ cầu; tưới máu kém → sốc nhiễm khuẩn
Rốn	Viêm rốn (đỏ, mủ, hôi) — đường vào nhiễm khuẩn
Mắt	Viêm kết mạc → **Chlamydia** (ngày 5–14), lậu
SpO_2 tay phải và chân	Chênh > 3% hoặc SpO_2 thấp không cải thiện với oxy → **tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch**, tăng áp phổi
Tim, mạch bẹn, gan	Tiếng thổi, gan to, **mạch bẹn yếu** (hẹp eo động mạch chủ) → bệnh tim
Bụng	Chướng bụng (nhiễm khuẩn, viêm ruột hoại tử); gan lách to (TORCH, giang mai)
Phổi	Ran nổ, ran ẩm nhỏ hạt (có thể không có), giảm thông khí một bên (tràn khí, tràn dịch)
Cân nặng, chiều dài, vòng đầu	So với lúc sinh; trẻ đủ tháng thường đã về cân lúc sinh trong 10–14 ngày đầu

11. "Sùi bọt cua" là gì, có đặc hiệu viêm phổi không?

Bọt nhỏ ở miệng do **dịch tiết đường thở trộn khí**, trẻ không ho khạc, nuốt được. Gợi ý viêm phổi sơ sinh nhưng **không đặc hiệu**: gặp cả ở **teo thực quản** (ngay sau sinh, kèm không đặt được sonde dạ dày), tăng tiết do thần kinh.

D. Tóm tắt – chẩn đoán – biện luận

12. Viết chẩn đoán cho bé này thế nào?

`Viêm phổi sơ sinh muộn, mắc phải cộng đồng – mức độ [nặng] – ngày [n] – nghĩ do [căn nguyên] – biến chứng [suy hô hấp…] – theo dõi nhiễm khuẩn huyết / viêm màng não – bệnh kèm [vàng da…]`

13. Bé này có suy hô hấp không, mức nào?

Dựa vào: **nhịp thở, rút lõm/co kéo, phập phồng cánh mũi, thở rên, tím, ngừng thở, SpO_2, tri giác, nhịp tim**; có thể dùng **Silverman**. Dấu hiệu nặng ở sơ sinh: **cơn ngừng thở, tím, thở rên, SpO_2 < 90%**, nhịp tim chậm, li bì, giảm trương lực. *Bẫy: thở chậm lại + li bì = mệt cơ, không phải đỡ.*

14. Biện luận căn nguyên ở trẻ 25 ngày tuổi?

Tác nhân	Gợi ý
Virus: RSV, cúm, á cúm, hMPV, adenovirus	Người nhà cảm, chảy mũi, khò khè/ran lan tỏa; RSV ở sơ sinh hay gây **ngừng thở**
Liên cầu B (khởi phát muộn), E. coli, Listeria	Mẹ mang liên cầu B, không dự phòng; bệnh cảnh **nhiễm khuẩn huyết**, hay kèm **viêm màng não**
Tụ cầu vàng	Mụn mủ da, viêm rốn; tiến triển nhanh, **bóng khí, tràn mủ, tràn khí**
Phế cầu	Ít hơn ở sơ sinh; người nhà nhiễm
Chlamydia trachomatis	Thường 1–3 tháng (có thể bắt đầu từ tuần 2–3): **không sốt**, ho từng tiếng (staccato), thở nhanh, **viêm kết mạc trước đó**, mẹ nhiễm Chlamydia; **bạch cầu ái toan tăng**; X-quang ứ khí + thâm nhiễm kẽ
Ho gà	Mẹ chưa tiêm Tdap, người lớn ho kéo dài; nhũ nhi nhỏ: **ho cơn không có tiếng rít, tím, ngừng thở**, không sốt, giữa cơn bình thường; **tăng lympho** rõ
Vi khuẩn bệnh viện: Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, MRSA, nấm	Mới nằm viện/thở máy, catheter
Hít sặc sữa	Ho sặc khi bú, trào ngược, rối loạn nuốt; rò khí – thực quản thể H (sặc mỗi lần bú, viêm phổi tái diễn)

15. Chẩn đoán phân biệt suy hô hấp ở trẻ 25 ngày tuổi?

- **Tim bẩm sinh**: tổn thương **phụ thuộc ống động mạch** biểu hiện khi ống đóng (tuần 1–3): tím, sốc, mạch bẹn yếu, chênh SpO_2 tay – chân; **shunt trái → phải lớn** (thông liên thất…) gây suy tim từ tuần 4–6 khi sức cản phổi giảm: thở nhanh, ra mồ hôi khi bú, gan to, tiếng thổi.
- **Nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não** (thở nhanh do toan chuyển hóa).
- **Viêm tiểu phế quản** (RSV) — ở sơ sinh xử trí thận trọng như nhiễm khuẩn nặng.
- **Ho gà**.
- **Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh**: thở nhanh sâu do toan, nôn, li bì, hạ đường huyết, tăng amoniac.
- **Hít sặc / trào ngược, rò khí – thực quản thể H**.
- **Tắc đường thở trên**: tắc mũi (sơ sinh thở mũi bắt buộc), mềm sụn thanh quản (thở rít).
- Tràn khí màng phổi, thoát vị hoành biểu hiện muộn, dị dạng phổi bẩm sinh (CPAM), thiếu máu nặng.

16. Làm sao phân biệt tím do tim với tím do phổi?

Do phổi: suy hô hấp rõ (rút lõm, thở rên), tím **cải thiện khi thở oxy**, $PaCO_2$ thường tăng. **Do tim (tím)**: thở nhanh "êm" (ít co kéo), tím **không cải thiện** khi thở oxy; **nghiệm pháp tăng oxy**: thở oxy 100% mà PaO_2 vẫn < 100–150 mmHg → nghĩ tim bẩm sinh tím; chênh SpO_2 trước – sau ống; khám tim, X-quang (bóng tim, tuần hoàn phổi), **siêu âm tim**.

E. Cận lâm sàng

17. Bé cần làm những xét nghiệm gì?

Xét nghiệm	Mục đích / đọc kết quả
Công thức máu	BC tăng hoặc **giảm** (giảm gợi ý nặng), **tỷ lệ bạch cầu non/tổng bạch cầu đa nhân (I/T) ≥ 0,2** gợi ý nhiễm khuẩn; tiểu cầu giảm; **BC ái toan tăng** (Chlamydia), **lympho tăng** (ho gà); thiếu máu
CRP (± PCT)	Một lần đơn lẻ kém nhạy; **CRP nối tiếp 24–48 giờ** bình thường giúp loại nhiễm khuẩn huyết
Cấy máu (trước kháng sinh)	Bắt buộc ở sơ sinh nghi nhiễm khuẩn nặng
Chọc dịch não tủy	Sơ sinh nghi nhiễm khuẩn nặng/cấy máu dương: **loại trừ viêm màng não** (thay đổi liều và thời gian kháng sinh). Hoãn khi trẻ **không ổn định** hô hấp, huyết động, rối loạn đông máu — vẫn cho kháng sinh ngay
Tổng phân tích nước tiểu ± cấy (lấy bằng sonde)	Nhiễm khuẩn tiết niệu ở sơ sinh, nhất là trẻ trai chưa cắt bao quy đầu
X-quang ngực	Đông đặc, thâm nhiễm kẽ, ứ khí (Chlamydia, virus), bóng khí/tràn mủ (tụ cầu), tràn khí; bóng tim, tuần hoàn phổi
SpO_2, khí máu	Mức độ suy hô hấp, toan chuyển hóa (nhiễm khuẩn huyết, bệnh chuyển hóa)
Đường máu, điện giải, calci	Hạ/tăng đường huyết, hạ natri (SIADH), hạ calci
Bilirubin (toàn phần, trực tiếp)	Vàng da kéo dài: tăng trực tiếp → ứ mật, nhiễm khuẩn
PCR dịch tỵ hầu: RSV, cúm, ho gà; **PCR Chlamydia** (tỵ hầu/kết mạc)	Định hướng điều trị (oseltamivir, macrolid), cách ly
Siêu âm tim	Khi nghi tim bẩm sinh, tăng áp phổi

18. Vì sao phải chọc dịch não tủy dù chẩn đoán là viêm phổi?

Ở sơ sinh nhiễm khuẩn dễ lan theo máu; viêm màng não có thể **không có dấu hiệu màng não** (chỉ li bì, bú kém, thóp phồng muộn); và **cấy máu âm tính không loại trừ** viêm màng não. Nếu có viêm màng não thì **liều cao hơn và thời gian dài hơn** (14–21 ngày tùy tác nhân).

F. Điều trị

19. Nguyên tắc điều trị?

(1) **Hồi sức, hỗ trợ hô hấp**: thông thoáng đường thở (hút mũi miệng, tư thế), oxy, CPAP/thở máy khi cần; (2) **kháng sinh tiêm sớm** (sau lấy cấy máu, không trì hoãn vì chọc dò); (3) **giữ ấm**, phòng hạ thân nhiệt; (4) **dinh dưỡng, dịch, đường huyết**; (5) điều trị biến chứng; (6) theo dõi sát.

20. Chọn kháng sinh gì, liều cho trẻ 25 ngày tuổi?

Ampicillin + gentamicin (WHO, lựa chọn đầu tay).

Thuốc	Liều trẻ 2–4 tuần tuổi (WHO Pocket Book 2013)
Ampicillin	**50 mg/kg/lần mỗi 8 giờ** (tuần đầu: mỗi 12 giờ). Viêm màng não: liều cao hơn
Gentamicin	**7,5 mg/kg 1 lần/ngày** (tuần đầu: 5 mg/kg, nhẹ cân 3 mg/kg)
Cefotaxime (thay/kèm)	50 mg/kg/lần mỗi 6–8 giờ — khi nghi viêm màng não, Gram âm, chức năng thận kém

Liều sơ sinh thay đổi theo tuổi sau sinh, tuổi thai, cân nặng và nguồn (WHO, Neofax, BNF-C) → khi thi nói nguyên tắc và đối chiếu phác đồ bộ môn.

Nghi **tụ cầu** (mụn mủ, bóng khí) → thêm **cloxacillin/oxacillin** (MSSA) hoặc **vancomycin** (MRSA). Nghi **vi khuẩn bệnh viện** → theo kháng sinh đồ tại chỗ (cefepime, carbapenem…). **Chlamydia/ho gà** → **azithromycin** (Chlamydia 20 mg/kg/ngày × 3 ngày; ho gà 10 mg/kg/ngày × 5 ngày ở trẻ < 6 tháng). **Cúm** → oseltamivir.

21. Vì sao ampicillin + gentamicin mà không dùng cephalosporin đơn độc?

Ampicillin phủ **Listeria và Enterococcus** — hai tác nhân **cephalosporin không có tác dụng**; phủ liên cầu B. **Gentamicin** phủ **Gram âm** (E. coli, Klebsiella) và **hiệp đồng** với ampicillin. Cephalosporin III dùng rộng rãi ở sơ sinh còn làm tăng nguy cơ **nấm Candida xâm lấn** và vi khuẩn kháng.

22. Vì sao không dùng ceftriaxone ở sơ sinh?

Đẩy bilirubin khỏi albumin → nguy cơ vàng da nhân; **kết tủa với calci** (không dùng cùng dịch truyền chứa calci). Dùng **cefotaxime** thay thế.

23. Gentamicin dùng thế nào, theo dõi gì?

1 lần/ngày (diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ, có hậu tác dụng kháng sinh). Theo dõi **chức năng thận, nồng độ đáy** (nếu có), **thính lực** (sàng lọc thính lực sơ sinh); tránh dùng kéo dài, tránh phối hợp thuốc độc thận.

24. Dùng macrolid cho trẻ < 6 tuần lưu ý gì? Liên quan gì đến bé trai này?

Erythromycin (và ít hơn là azithromycin) ở trẻ **< 6 tuần** làm tăng nguy cơ **hẹp phì đại môn vị** — bệnh **hay gặp ở trẻ trai**, tuổi 3–6 tuần. Vẫn dùng khi có chỉ định (ho gà, Chlamydia — lợi ích lớn hơn), **azithromycin ưu tiên**, dặn theo dõi **nôn vọt sau bú**.

25. Kháng sinh dùng bao lâu?

Viêm phổi sơ sinh: thường **7–10 ngày** (WHO: ít nhất 7 ngày cho nhiễm khuẩn nặng). Cấy máu dương liên cầu B: 10 ngày. **Viêm màng não**: 14 ngày (liên cầu B), **21 ngày** (Gram âm). Nếu cuối cùng chẩn đoán không phải nhiễm khuẩn (cấy âm, CRP nối tiếp bình thường, trẻ khỏe, có nguyên nhân khác) → có thể **ngừng sau 36–48 giờ**.

26. Oxy và hỗ trợ hô hấp cho bé thế nào?

Oxy khi **SpO_2 < 90%**, hoặc tím, ngừng thở, suy hô hấp nặng; giữ SpO_2 khoảng **90–95%** (tránh thừa oxy, nhất là trẻ non tháng – bệnh võng mạc). Hút thông mũi (sơ sinh thở mũi). Không đáp ứng → **CPAP**/HFNC; **thở máy** khi ngừng thở tái diễn, SpO_2 không giữ được, tăng CO_2 + toan, sốc. Ngừng thở do ho gà/RSV: kích thích, bóp bóng, theo dõi monitor.

27. Nuôi dưỡng và dịch cho bé?

Ưu tiên **sữa mẹ**. Bú được → bú mẹ, cữ nhỏ, nhiều lần. **Thở rất nhanh (> 70)**, bú yếu, sặc → **sữa mẹ vắt qua sonde dạ dày**. Không ăn được → truyền dịch (nhu cầu ở tuổi này khoảng **150 mL/kg/ngày**, điều chỉnh theo lâm sàng, natri, nước tiểu), có **glucose** để phòng hạ đường huyết. Cân hằng ngày.

28. Giữ ấm thế nào, vì sao quan trọng?

Hạ thân nhiệt làm **tăng tiêu thụ oxy, hạ đường huyết, toan chuyển hóa**, tăng tử vong. Giữ ấm: phòng ấm, quấn khăn, đội mũ, **chăm sóc kiểu chuột túi (da kề da)** khi ổn định, lồng ấp/giường sưởi khi cần; giữ thân nhiệt 36,5–37,5 °C.

29. Có dùng corticoid, thuốc ho, khí dung salbutamol, vật lý trị liệu không?

Không thường quy. Không thuốc ho, long đờm; không vật lý trị liệu hô hấp thường quy; salbutamol không hiệu quả ở viêm tiểu phế quản/viêm phổi sơ sinh; corticoid không có chỉ định trong viêm phổi sơ sinh.

G. Theo dõi – biến chứng – ra viện – phòng bệnh

30. Theo dõi những gì?

Monitor SpO_2, nhịp thở, nhịp tim, cơn ngừng thở liên tục; thân nhiệt; tri giác, trương lực, thóp; **đường máu**; lượng bú/dịch vào – nước tiểu; **cân nặng hằng ngày**; vàng da; dấu hiệu biến chứng (tràn khí: xấu đi đột ngột, giảm thông khí một bên). Đánh giá đáp ứng sau **48–72 giờ**; CRP nối tiếp.

31. Biến chứng của viêm phổi sơ sinh?

Suy hô hấp, cơn ngừng thở; **nhiễm khuẩn huyết, sốc**; **viêm màng não**; **tràn khí màng phổi**, tràn dịch/tràn mủ màng phổi, áp xe, bóng khí (tụ cầu); **hạ đường huyết, hạ thân nhiệt**, rối loạn điện giải (SIADH); vàng da tăng; về lâu dài: viêm tiểu phế quản tắc nghẽn (adenovirus), khò khè tái diễn (RSV).

32. Sau 48–72 giờ không đáp ứng, nghĩ gì?

(1) **Sai chẩn đoán**: tim bẩm sinh, ho gà, bệnh chuyển hóa, rò khí – thực quản, hít sặc; (2) **sai thuốc**: tụ cầu/MRSA, vi khuẩn bệnh viện kháng thuốc, Chlamydia/ho gà (β-lactam vô hiệu), virus, nấm; (3) **biến chứng**: viêm màng não, tràn mủ/tràn khí, áp xe; (4) **cơ địa**: suy giảm miễn dịch bẩm sinh, HIV. Làm lại: khám, X-quang, siêu âm, cấy, dịch não tủy, PCR, siêu âm tim.

33. Tiêu chuẩn ra viện?

Hết suy hô hấp, **SpO_2 ổn định khí trời**, **không còn cơn ngừng thở**, thân nhiệt ổn định không cần hỗ trợ, **bú tốt, tăng cân**, hoàn thành đủ liệu trình kháng sinh tiêm (hoặc chuyển phù hợp), gia đình biết dấu hiệu cần đưa trẻ đến ngay.

34. Tiên lượng bé?

Nêu yếu tố nặng có/không: **non tháng, nhẹ cân**, **cơn ngừng thở**, sốc, **viêm màng não**, tác nhân (tụ cầu, Gram âm kháng thuốc, ho gà sơ sinh), bệnh tim kèm, đáp ứng sau 48–72 giờ.

35. Tư vấn phòng bệnh cho mẹ và gia đình?

Bú mẹ hoàn toàn; rửa tay; hạn chế người ốm tiếp xúc trẻ (anh chị cảm, người lớn ho); **giữ ấm**; tránh khói thuốc. **Tiêm chủng**: trẻ theo lịch (BCG, viêm gan B, rồi lúc 2 tháng: 5/6 trong 1 có ho gà, Hib; phế cầu); **mẹ tiêm Tdap khi mang thai** (lần sau), cúm cho người chăm sóc ("tạo vòng bảo vệ"); RSV: nirsevimab cho trẻ hoặc vắc xin cho mẹ (32–36 tuần thai). Khám, điều trị Chlamydia/liên cầu B cho mẹ khi mang thai lần sau. **Dấu hiệu đưa trẻ đến ngay**: bú kém, ngừng thở, tím, thở nhanh, rút lõm, sốt hoặc lạnh, li bì, co giật.

H. Câu hỏi "xoáy" riêng cho sơ sinh

36. Trẻ 25 ngày tuổi sốt 38,5 °C, thở nhanh nhẹ, bú tốt — có điều trị ngoại trú được không?

Ở cơ sở có điều kiện: **không** — trẻ < 28 ngày (theo AAP 2021: 22–28 ngày) có sốt hoặc dấu hiệu nhiễm khuẩn phải **nhập viện, làm xét nghiệm (máu, nước tiểu, ± dịch não tủy) và kháng sinh tiêm**. WHO (nơi không chuyển viện được): trẻ **7–59 ngày chỉ có thở nhanh đơn độc** có thể dùng **amoxicillin uống** — chỉ là phương án khi không thể chuyển viện, không áp dụng khi có dấu hiệu khác.

37. Vì sao trẻ sơ sinh hay ngừng thở trong viêm phổi/RSV/ho gà?

Trung tâm hô hấp chưa trưởng thành, đáp ứng với thiếu oxy là **ức chế hô hấp** (thay vì tăng thông khí như trẻ lớn); mệt cơ; RSV và ho gà gây ngừng thở trung ương; tắc mũi, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, nhiễm khuẩn huyết cũng gây ngừng thở. Trẻ càng nhỏ, càng non tháng càng dễ ngừng thở.

38. Ho gà ở trẻ 25 ngày khác trẻ lớn thế nào?

Trẻ nhỏ **thường không có tiếng rít cuối cơn**, biểu hiện bằng **cơn tím, ngừng thở, nhịp chậm**, có thể đột tử; không sốt. **Tăng lympho** rõ; bạch cầu rất cao (> 30 000/mm^3) gợi ý thể nặng (tăng áp phổi). Điều trị **azithromycin**; dự phòng cho người tiếp xúc trong nhà.

39. Viêm phổi do Chlamydia trachomatis: nhận biết và điều trị?

Lây khi sinh qua đường âm đạo mẹ nhiễm; viêm kết mạc ngày 5–14, viêm phổi thường **1–3 tháng**. **Không sốt**, ho từng tiếng (staccato), thở nhanh, ran nổ; **BC ái toan tăng**; X-quang ứ khí + thâm nhiễm kẽ. Điều trị **azithromycin 20 mg/kg/ngày × 3 ngày** (hoặc erythromycin 50 mg/kg/ngày chia 4 × 14 ngày); điều trị mẹ và bạn tình; theo dõi hẹp môn vị.

40. Bé có vàng da ở ngày 25 — liên quan gì?

Vàng da > 14 ngày ở trẻ đủ tháng là **vàng da kéo dài** → đo **bilirubin trực tiếp**: tăng trực tiếp → **ứ mật** (teo đường mật — cần phát hiện sớm), **nhiễm khuẩn** (huyết, tiết niệu), suy giáp, galactosemia. Nhiễm khuẩn có thể làm vàng da nặng lên. Vàng da do sữa mẹ là chẩn đoán loại trừ.

> **Bẫy hay mất điểm ở ca sơ sinh:** (1) phân loại "viêm phổi nhẹ, điều trị ngoại trú" cho trẻ < 28 ngày; (2) quên **thân nhiệt, đường máu, thóp**; (3) không nghĩ **viêm màng não**, không đề cập chọc dịch não tủy; (4) cho **ceftriaxone**; (5) dùng cephalosporin đơn độc (bỏ sót Listeria); (6) không nghĩ **tim bẩm sinh** (không đo SpO_2 tay – chân, không bắt mạch bẹn); (7) quên hỏi **tiền sử mẹ** (ối vỡ sớm, liên cầu B, Chlamydia, tiêm Tdap); (8) kê thuốc ho, salbutamol.

Liều sơ sinh trong tài liệu theo WHO Pocket Book 2013 (trẻ 2–4 tuần tuổi, đủ tháng); azithromycin cho Chlamydia và ho gà theo AAP Red Book. Thang Silverman và cách phân loại sớm/muộn, phân độ suy hô hấp: đối chiếu giáo trình bộ môn.